

■ DATOS SINTÉTICOS - SOLO PARA PRUEBAS - NO ES PACIENTE REAL ■

Este documento fue generado automáticamente para el desarrollo del clinical-extractor de SICA. No contiene PHI ni representa una paciente real. Cualquier semejanza con un caso clínico real es coincidencia.

HISTORIA CLÍNICA OBSTÉTRICA

Centro Materno-Infantil (sintético) — Consultorio de Alto Riesgo Obstétrico

FILIACIÓN

Nombre:	PACIENTE SINTÉTICA - NO REAL
Edad:	28 años
Estado civil:	Conviviente
Ocupación:	Asistente contable
Fecha de elaboración:	20/03/2026

ANTECEDENTES GINECO-OBSTÉTRICOS

Fórmula obstétrica: G2 P1 (1 parto vaginal previo, 2023, embarazo único, sin complicaciones).

Niega antecedentes familiares de gemelaridad. Concepción espontánea, sin tratamientos de fertilidad.

GESTACIÓN ACTUAL

FUM:	08/10/2025
FPP:	15/07/2026
EG actual (por FUM):	24 semanas
Tipo de embarazo:	Gemelar bicorial biamniótico
Controles prenatales:	4 al momento

Eco a las 12 semanas confirmó corionicidad: dos sacos, dos placentas, signo lambda positivo. Última eco (18 semanas) con crecimiento concordante entre ambos fetos.

ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA (18 SEMANAS)

Feto A: vivo, presentación cefálica, biometría acorde a EG, peso fetal estimado 235 g. Feto B: vivo, presentación podálica, biometría acorde a EG, peso fetal estimado 240 g. Discordancia de peso 2.1% (no patológica). Dos placentas independientes. Líquido amniótico en cantidad normal en ambos sacos.

EXAMEN FÍSICO ACTUAL

PA 108/68 mmHg. FC 82 lpm. T° 36.5°C. Peso 64.0 kg. Talla 1.62 m. AU 26 cm (acorde a gestación gemelar). Edema MMII (-/-). LCF Feto A 148 lpm, LCF Feto B 152 lpm.

LABORATORIOS (15/03/2026)

Analito	Resultado	Unidad	Observación
Hemoglobina	10.2	g/dL	Anemia leve gestacional
Hematocrito	31.0	%	Limítrofe bajo
Glucosa basal	84	mg/dL	Normal
TSH	1.9	mUI/L	Dentro de rango
HIV (ELISA)	No reactivo	—	Negativo
Sífilis (RPR)	No reactivo	—	Negativa

PLAN

1. Suplementación con sulfato ferroso 300 mg VO c/24 h. 2. Ácido fólico y calcio según pauta de alto riesgo. 3. Control quincenal a partir de semana 26. 4. Eco obstétrica + Doppler cada 4 semanas para vigilar crecimiento y discordancia. 5. Educación sobre signos de alarma específicos de gestación múltiple. 6. Plan de parto a definir según evolución; cesárea si presentación no cefálica del Feto A.

